CROIX-ROUGE FRANÇAISE

Fiche V - C - 3

Version 2.0.0

Du 01/09/2026

TECHNIQUES ET MATÉRIELS

Rédacteurs :
Daniel MEYRAN
Julien PAPOZ
Denis LARGER

Compressions thoraciques chez le nourrisson (OVA)

INDICATIONS

Obstruction complète des voies aériennes par un corps étranger chez un nourrisson conscient et qui persiste malgré les claques dans le dos (Fiche IV-B-1).

JUSTIFICATION

Chez le nourrisson les compressions abdominales, trop traumatisantes, sont remplacées par des compressions thoraciques pour comprimer l'air contenu dans les poumons, débloquer et expulser le corps étranger qui obstrue les VA.

Suivant l'importance et la position du corps étranger, plusieurs pressions successives peuvent être nécessaires pour l'expulser.

MATÉRIEL

- Pas de matériel spécifique

RÉALISATION

- Tourner le nourrisson en soutenant sa tête et pour que sa face soit côté ciel.
- Poser le nourrisson de telle sorte que :
  - son dos et sa tête reposent directement sur les deux cuisses du secouriste ;
  - sa tête soit plus basse que le reste du corps.
- Comme pour les compressions thoraciques pour un arrêt cardiaque (fig. 1) :
  - entourer le thorax du nourrisson avec les mains ;
  - placer deux pouces, l'un sur l'autre, au milieu du sternum.
- Effectuer de 1 à 5 compressions successives, en relâchant complètement entre chacune. La profondeur de compression est au-delà d'un tiers de la hauteur du thorax.



Figure 1 : retournement et compressions thoraciques

RISQUES & CONTRAINTES

Des complications par traumatisme des organes internes, des côtes ou du sternum peuvent survenir après ces manœuvres.

Ce risque ne doit pas diminuer la qualité des compressions thoraciques qui est absolument nécessaire au rejet du corps étranger.

ÉVALUATION

Efficace, cette technique permet :

- le rejet du corps étranger,
- l'apparition de toux,
- l'apparition de pleurs ou de cris,
- la reprise d'une respiration normale.